

	PROTOCOLO DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE IAAS INSTITUCIONAL	Código:	GCL 3.2
		Fecha:	Noviembre 2025
		Versión:	1.0
		Vigencia:	Noviembre 2030
		Página:	Página 1 de 26

PROTOCOLO DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE IAAS INSTITUCIONAL

**Unidad de Calidad y Seguridad de Usuario, CESFAM Dr.
Orlando Leyton A. Peralillo**

Elaborado por: Sandy Guajardo P	Revisado por: María José Solís L	Aprobado por: Dr. Cristian Cárdenas E.
Cargo : Enfermera IAAS	Cargo: Área Técnica Unidad de Calidad	Cargo: Director CESFAM Peralillo
Fecha: 10-11-2025	Fecha: 14-11-2025	Fecha: 17-11-2025
Firma:  Sandy Guajardo Padilla R.U.T.: 18.750.793-6 ENFERMERA	Firma:  María José Solís Letelier Rut: 16.432.757-4 Enfermera	Firma:   CRISTIAN CÁRDENAS ESPINOZA DIRECTOR CESFAM PERALILLO

	PROTOCOLO DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE IAAS INSTITUCIONAL	Código:	GCL 3.2
		Fecha:	Noviembre 2025
		Versión:	1.0
		Vigencia:	Noviembre 2030
		Página:	Página 2 de 26

I. INTRODUCCIÓN

El personal que brinda atención de salud está en riesgo de adquirir micro organismos patógenos a consecuencia de sus labores, pero también de transmitirlos a los usuarios/as y de servir como vehículo de transmisión entre personas, por ello es importante describir las precauciones y realizar actividades de supervisión para evitar dicha transmisión, lo cual disminuirá la morbilidad, costos adicionales, riesgo para el personal de salud y eventuales implicancias médico legales en salud.

El presente documento, que es válido para CESFAM Dr. Orlando Leyton A, Postas de Salud Rurales, Servicio de Urgencia Rural, determina la presente versión de normativa de prevención y control de IAAS institucional.

II. OBJETIVOS.

a. Objetivo General.

Establecer lineamientos y procedimientos estandarizados para prevenir, vigilar y controlar las Infecciones Asociadas a la Atención de Salud (IAAS), mejorando la seguridad del paciente, disminuir la morbilidad y mortalidad asociada, y garantizar una atención de calidad.

b. Objetivos específicos.

- Describir en un documento de carácter institucional las medidas de prevención de IAAS que considere: precauciones estándar, prevención de infecciones asociadas a catéter vascular y urinario junto al uso de antisépticos y desinfectantes.

	PROTOCOLO DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE IAAS INSTITUCIONAL	Código:	GCL 3.2
		Fecha:	Noviembre 2025
		Versión:	1.0
		Vigencia:	Noviembre 2030
		Página:	Página 3 de 26

- Definir indicador, umbral de cumplimiento y evaluación periódica para los métodos y procedimientos determinados en el presente documento.
- Evaluar periódicamente la adherencia a las normas y protocolos de prevención de IAAS, aplicando pautas de supervisión para mejorar los procesos.

III. ALCANCE.

Funcionarios/as del CESFAM Dr. Orlando Leyton A, Postas de Salud Rurales, Servicio de Urgencia Rural de atención directa al usuario, independiente de su unidad y horario de trabajo.

IV. DESIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES.

Enfermera IAAS: Responsable de elaboración, difusión y supervisión del cumplimiento de normativas en toda la institución.

Profesionales clínicos: Responsables de conocer, difundir, cumplir y hacer cumplir normativa.

TENS y TONS: Responsables de conocer, cumplir y hacer cumplir normativa.

Auxiliares de Servicio: Encargados de conocer y cumplir la normativa.

Encargado de Unidad de Calidad: Encargado de la evaluación global de los indicadores y apoyar el ciclo de mejora institucional.

V. DEFINICIONES.

FLUIDOS CORPORALES: Se entiende por fluido corporal a todas las secreciones o líquidos biológicos, fisiológicos o patológicos que se producen en el organismo.

	PROTOCOLO DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE IAAS INSTITUCIONAL	Código:	GCL 3.2
		Fecha:	Noviembre 2025
		Versión:	1.0
		Vigencia:	Noviembre 2030
		Página:	Página 4 de 26

LIMPIEZA: Proceso de separación por medios mecánicos y/o físicos de la suciedad depositada en las superficies inertes (muebles, pisos y muros) que constituyen un soporte físico y nutritivo de microorganismos. Su objetivo es la eliminación física de materia orgánica y de la contaminación de los objetos.

DESINFECCIÓN: Significa destrucción de todas las formas de vida de los patógenos que se encuentran en objetos inanimados, pero **no elimina esporas bacterianas**.

DESINFECTANTE: Se define como germicidas que pueden ser utilizados en las superficies ambientales y de los artículos médicos. Se usan para la eliminación de microorganismos que se encuentran en superficies inanimadas.

DESINFECCIÓN CONCURRENTE: Eliminar los agentes infecciosos que se encuentran en las superficies (muebles, muros, pisos) mediante la aplicación de agentes desinfectantes, inmediatamente después de una atención en que exista contaminación con fluidos corporales.

DESINFECCIÓN TERMINAL: Eliminar agentes infecciosos que se encuentran en las superficies (muebles, muros, cortinajes y pisos), mediante la aplicación de agentes desinfectantes, con periodicidad semanal.

ANTISÉPTICO: Agentes germicidas usados sobre la piel y otros tejidos vivos para inhibir o eliminar los microorganismos.

TÉCNICA ASÉPTICA: Es el conjunto de procedimientos y actividades que realiza el personal de salud, conducentes a disminuir al mínimo la contaminación microbiana, durante la atención de usuarios/as.

ESTERILIZACIÓN: Es la eliminación completa de toda forma de vida microbiana de objetos inanimados **incluyendo esporas**. Puede conseguirse a través de métodos físicos, químicos o gaseosos.

FLUIDO CORPORAL DEL ALTO RIESGO: Son todos los fluidos corporales que efectivamente se asocian a la transmisión de los patógenos sanguíneos como: sangre,

	PROTOCOLO DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE IAAS INSTITUCIONAL	Código:	GCL 3.2
		Fecha:	Noviembre 2025
		Versión:	1.0
		Vigencia:	Noviembre 2030
		Página:	Página 5 de 26

secreciones genitales, líquidos de cavidades normalmente estériles y cualquier otro fluido, secreción y excreción con sangre visible.

CAMPO ESTERIL: Se llama campo estéril a una superficie sin gérmenes que puedan contaminar e infectar el material estéril a utilizar.

CATETERIZACIÓN VASCULAR: Es la canalización de un vaso sanguíneo venoso o arterial realizada por medio de un catéter a través de una punción o incisión.

CATETERIZACIÓN URINARIA: Es la inserción de una sonda vesical a través de la uretra, hasta el interior de la vejiga, utilizando para ello técnica estéril.

VI. DESARROLLO DEL PROCESO.

Para dar cumplimiento a la prevención de las IAAS en los presentes centros de salud se considerarán las siguientes medidas de acuerdo a los elementos medibles de la Pauta de Cotejo de Atención Abierta que son: Precauciones estándar, infecciones asociadas a la instalación de catéter venoso, urinario y uso de antisépticos y desinfectantes.

1. PRECAUCIONES ESTÁNDAR:

RESPONSABLE DE SU APLICACIÓN: Todo el personal del establecimiento de acuerdo a sus funciones, responsabilidades y/o eventos especiales.

a. HIGIENE DE MANOS:

Objetivos

- Eliminar la flora microbiana transitoria y disminuir la flora microbiana normal para prevenir la diseminación por vía portable.
- Realizar una atención segura a los usuarios/as a través de manos libres de microorganismos patógenos.

	PROTOCOLO DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE IAAS INSTITUCIONAL	Código:	GCL 3.2
		Fecha:	Noviembre 2025
		Versión:	1.0
		Vigencia:	Noviembre 2030
		Página:	Página 6 de 26

Consideraciones Generales:

- Se debe disponer de lavamanos, dispensador de jabón, jabón líquido y toalla desechable.
- **Previo al lavado el personal clínico debe cumplir con: uñas cortas (que no sobrepase el largo de la falange distal), limpias y sin esmalte.** No se deben utilizar uñas postizas. Sólo podrán usar esmaltes los funcionarios que por alguna indicación médica específica deban usarlo como mecanismo protector ante alguna patología de tipo fúngica.
- **Retirar joyas y relojes.**
- La duración del lavado de manos clínico es de 40 segundos y el lavado quirúrgico de 2 minutos.
- El secado de manos se debe realizar con toalla de papel desechable en el lavado clínico y con compresa o toalla estéril en el lavado quirúrgico.

Formas del lavado de manos:

A- En forma convencional (con agua y jabón)

B- En seco, no convencional (con productos basados en alcohol)

Tiempos en el lavado de manos:

Antes de:	Tipo de lavado
Empezar a trabajar	Siempre convencional
Contacto con un usuario/a.	Convencional o en seco
Antes de realizar una tarea limpia/aséptica.	Convencional o en seco
Manipular un dispositivo invasivo.	Convencional o en seco
Colocarse guantes	Convencional o en seco
Realizar un procedimiento invasivo	Siempre convencional
Antes de usar, recepcionar y guardar material limpio o estéril.	Convencional o en seco

	PROTOCOLO DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE IAAS INSTITUCIONAL	Código:	GCL 3.2
		Fecha:	Noviembre 2025
		Versión:	1.0
		Vigencia:	Noviembre 2030
		Página:	Página 7 de 26

Entre:	Tipo de lavado
Usuario/a y usuario/a	Convencional o en seco
Procedimientos en un mismo paciente, en sitios diferentes.	Convencional o en seco

Después de:	Tipo de lavado
Entrar en contacto con líquidos o excreciones corporales, mucosas, piel no intacta o vendajes de heridas.	Siempre convencional
El contacto con usuarios/as.	Convencional o en seco
Remoción de guantes	Convencional o en seco
Realizar procedimientos invasivos.	Siempre convencional
Cuando las manos están visiblemente sucias o contaminadas	Siempre convencional
Después de tocar objetos posiblemente contaminados.	Siempre convencional
Tener contacto con objetos localizados en la unidad del paciente	Convencional o en seco
Ir al baño, estornudar	Siempre convencional

Tipos de lavado/higiene de manos:

- Lavado de manos Doméstico.
- Lavado de manos Clínico.
- Lavado de manos Quirúrgico (No se realiza en nuestros establecimientos por el tipo de prestaciones y complejidad).
- Higiene de manos con Alcohol Gel.

Procedimiento: Lavado Clínico de Manos.

Duración: 40 segundos.

Tipo de jabón a utilizar: jabón antiséptico o jabón de glicerina.

1. Mójese las manos con agua. Si puede, cierre la llave del agua con los codos, mientras realiza el procedimiento.

	PROTOCOLO DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE IAAS INSTITUCIONAL	Código:	GCL 3.2
		Fecha:	Noviembre 2025
		Versión:	1.0
		Vigencia:	Noviembre 2030
		Página:	Página 8 de 26

2. Deposite en la palma de la mano una cantidad de jabón suficiente para cubrir todas las superficies de las manos.
3. Frótese las palmas de las manos entre sí.
4. Frótese la palma de la mano derecha contra el dorso de la mano izquierda entrelazando los dedos y viceversa.
5. Frótese las palmas de las manos entre sí con los dedos entrelazados.
6. Frótese el dorso de los dedos de una mano con la palma de la mano opuesta, agarrándose los dedos.
7. Frótese con un movimiento de rotación el pulgar izquierdo, atrapándolo con la palma de la mano derecha y viceversa;
8. Frótese la punta de los dedos de la mano derecha, con la palma de la mano izquierda haciendo un movimiento de rotación y viceversa;
9. Abra la llave con el codo y enjuáguese las manos con agua.
10. Séquese con una toalla desechable.
11. Sírvasse la toalla para cerrar la llave.
12. Sus manos son seguras. (Anexo 1)

Procedimiento: Higiene de manos con alcohol gel

Duración: 20 a 30 segundos.

Requiere tener manos libres de materia orgánica o fluidos corporales.

1. Deposite en la palma de la mano una dosis de producto suficiente para cubrir todas las superficies.
2. Frótese las palmas de las manos entre sí.
3. Frótese la palma de la mano derecha contra el dorso de la mano izquierda entrelazando los dedos y viceversa;
4. Frótese las palmas de las manos entre sí con los dedos entrelazados;

	PROTOCOLO DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE IAAS INSTITUCIONAL	Código:	GCL 3.2
		Fecha:	Noviembre 2025
		Versión:	1.0
		Vigencia:	Noviembre 2030
		Página:	Página 9 de 26

5. Frótese el dorso de los dedos de una mano con la palma de la mano opuesta, agarrándose los dedos;
6. Frótese con un movimiento de rotación el pulgar izquierdo, atrapándolo con la palma de la mano derecha y viceversa;
7. Frótese la punta de los dedos de la mano derecha, con la palma de la mano izquierda haciendo un movimiento de rotación y viceversa.
8. Una vez secas, sus manos son seguras.

2. USO DE EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL (EPP):

Constituyen barreras de protección ocular, facial, corporal y de la ropa (guantes, mascarilla, lentes, delantal, pechera). Se utilizan al estar en contacto con sangre, fluidos corporales, materiales contaminados, mucosas y piel no indemne (heridas). Deben estar: indemnes, cambiar entre pacientes y lavarse las manos al retirarlos.

a. USO DE GUANTES CLÍNICOS:

Objetivo: Prevenir que el material contaminado se ponga en contacto con la piel de las manos del operador y así prevenir que los agentes microbianos se transmitan a otras personas, incluido el personal de salud.

Indicaciones de uso Guantes clínicos:

- En procedimiento de pre analítica (recepción y toma de muestras).
- Administración de medicamentos por vía endovenosa. (en caso de que amerite su uso).
- Procedimientos de enfermería (curaciones, sondeos, en algunos exámenes físicos).
- Atención odontológica.
- Atención gineco-obstétrica (sin trabajo de parto).

	PROTOCOLO DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE IAAS INSTITUCIONAL	Código:	GCL 3.2
		Fecha:	Noviembre 2025
		Versión:	1.0
		Vigencia:	Noviembre 2030
		Página:	Página 10 de 26

- Procedimientos que impliquen contaminación con sangre o fluidos corporales de alto riesgo y que no requieran de guante estéril.
- Deben ser colocados con lavado clínico de manos previo.

Procedimiento de utilización de guantes clínicos:

- Deben ser utilizados sólo mientras dure la técnica y luego retirar, no ejecutar actividades anexas.
- El uso de guantes no libera del lavado clínico de manos previo y posterior a la atención del usuario/a.
- El primer guante debe ser retirado tomándolo de su cara externa, luego traccionar hacia abajo para retirar sin tocar la parte externa.
- Se empuña o recoge el primer guante sacado con la mano que aún tiene el guante.
- Se introducen los dedos de la mano no enguantada por la caña en su cara interna y dándolo vuelta por completo para prevenir la contaminación de las manos, las que igual deben ser lavadas una vez retirado los guantes.

Los guantes no deben ser utilizados para actividades cotidianas como por ejemplo contestar el teléfono, accionar puertas, transportar pacientes en camillas, sillas de ruedas.

Indicaciones de uso Guantes Estériles:

- Instalación de catéter urinario.
- Procedimientos invasivos gineco-obstétricos (inserción de DIU o implantes, atención de parto)
- Curaciones avanzadas con compromiso óseo.
- Cuando se requiera hacer una curación y no se disponga de equipo estéril.

	PROTOCOLO DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE IAAS INSTITUCIONAL	Código:	GCL 3.2
		Fecha:	Noviembre 2025
		Versión:	1.0
		Vigencia:	Noviembre 2030
		Página:	Página 11 de 26

- Otros casos excepcionales.

Técnica colocación guantes estériles:

- Lávese las manos (tipo clínico o quirúrgico según corresponda).
- Tome el primer guante por su cara interna y colóqueselo.
- Tome el segundo guante con la mano ya enguantada, cogiendo por su cara externa, es decir, por el pliegue de la caña, de esta forma la mano enguantada no toca la cara interna y acomode (es decir, se toca guante con guante).

Técnica retiro guantes estériles:

- Después del uso retire el primer guante, cuidando de tomarlo por la caña y dándolo vuelta por completo. Puede eliminarlo inmediatamente o empuñarlo con la mano enguantada.
- Retire el segundo guante tomándolo por su cara interna y dándolo vuelta por completo. Deseche el guante.
- Lávese y séquese las manos.

Indicación de uso de guantes domésticos:

- Lavado de material quirúrgico y no quirúrgico.
- Manipulación de residuos domiciliarios y especiales.
- Aseo de las instalaciones (limpieza, concurrente, terminal).

Consideraciones en el manejo de guantes domésticos:

Después de cada procedimiento el operador, con los guantes puestos, deberá proceder a lavarlos con jabón o detergente jabonoso. Se sacan y se dejan secar.

b. PROTECCIÓN FACIAL: Antiparras protectoras / Mascarilla

Objetivo: Prevenir que el personal de salud se exponga a recibir material contaminado en la boca, nariz o conjuntiva ocular, si durante la atención hay posibilidad de salpicaduras de sangre, fluidos orgánicos, secreciones y excreciones.

	PROTOCOLO DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE IAAS INSTITUCIONAL	Código:	GCL 3.2
		Fecha:	Noviembre 2025
		Versión:	1.0
		Vigencia:	Noviembre 2030
		Página:	Página 12 de 26

Antiparras: Se utilizan para protección en procedimientos con riesgo de salpicaduras de fluidos corporales de alto y bajo riesgo y líquidos contaminados.

Usar en:

- Área sucia de Unidad de esterilización.
- En procedimientos odontológicos, podológicos, de salas IRA-ERA, procedimientos de lavado de contenedores de residuos especiales y domiciliarios.
- Todos aquellos procedimientos que impliquen riesgo de contaminación.

Mascarilla: se utilizan para la prevención de enfermedades que se transmiten por vía respiratoria.

Colocarla cubriendo boca y nariz de manera segura, luego higienizarse las manos.

Debe ser eliminada cada vez que se deje de usar o cada vez que se humedezca, por lo que no debe mantenerse colgada en el cuello, guardarse en el bolsillo del uniforme o dejarse en áreas contaminadas.

c. USO DE DELANTAL DESECHABLE NO ESTÉRIL.

Objetivo: Prevenir que el personal de salud se exponga a recibir material contaminado en el cuerpo si durante la atención hay posibilidad de salpicaduras de sangre, fluidos orgánicos, secreciones y excreciones.

Delantal desechable no estéril: Se utiliza en casos de riesgo de exposición a fluidos contaminados o líquidos corrosivos. Puede ser utilizado por auxiliares de servicio y profesionales, visitas en domicilio que impliquen procedimientos. A su vez por personal clínico donde deberá ser desechado una vez se termine el procedimiento.

	PROTOCOLO DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE IAAS INSTITUCIONAL	Código:	GCL 3.2
		Fecha:	Noviembre 2025
		Versión:	1.0
		Vigencia:	Noviembre 2030
		Página:	Página 13 de 26

d. PREVENCIÓN Y MANEJO DE MATERIAL CORTOPUNZANTE.

El manejo en este ámbito se expresa en Protocolo de manejo ante accidentes relacionados con sangre y fluidos corporales de riesgo, característica RH 4.2, donde se hace hincapié en 2 medidas generales para evitar accidentes cortopunzantes:

- No se recapsularán las agujas hipodérmicas independiente del uso que tuvieron.
- No se desmontarán agujas de sutura, bisturís y otros con las manos directamente. Se utilizarán para tal efecto portaagujas o pinzas Kelly 14 o 16 cm.

e. MANEJO DE REAS.

El manejo de residuos se describe en el manual de REAS de CESFAM.

f. GORRO DESECHABLE.

Se usa como medida protectora para evitar la caída accidental de cabello en el área de trabajo. Este debe cubrir completamente el cabello. Se deberá usar en:

Unidad de esterilización (área sucia y limpia)

En procedimientos odontológicos y podológicos.

g. TRANSPORTE DE MUESTRAS.

Se describe en Manual de Procedimientos de toma de muestras de exámenes de laboratorio y su traslado elaborado en el CESFAM; APL 1.2.

	PROTOCOLO DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE IAAS INSTITUCIONAL	Código:	GCL 3.2
		Fecha:	Noviembre 2025
		Versión:	1.0
		Vigencia:	Noviembre 2030
		Página:	Página 14 de 26

3. PREVENCIÓN DE INFECCIONES ASOCIADAS A PROCEDIMIENTOS INVASIVOS: CATÉTER VENOSO Y URINARIO.

Responsable de su aplicación: El procedimiento de cateterismo vesical y venoso es de responsabilidad exclusiva de la enfermera(o), matrona (o) u otro profesional capacitado. En ausencia de estos profesionales y la necesidad imperiosa de estos procedimientos, se autoriza a técnico paramédico capacitado para su instalación.

Condiciones previas para instalación de catéter vascular periférico y catéter urinario.

a) Catéter vascular periférico:

- Proceder a lavado clínico de manos.
- Usar barreras protectoras: guantes de procedimientos.
- Aseptizar la zona de punción con tórula embebida en alcohol 70° o toallitas de alcohol Pad realizando movimientos circulares durante 30 segundos.
- Cuando la piel se encuentre en malas condiciones higiénicas debe previamente lavarse con agua y jabón cosmético (glicerina).
- Si fracasa la cateterización, se deberá cambiar catéter y sitio de punción.
- Una vez instalado el catéter se debe cubrir con gasa estéril seca o apósitos adhesivos transparentes estériles.
- La fijación del catéter debe ser hecha de forma que no se desplace ni salga del sitio de punción.
- Registrar fecha de instalación, número de bránula.

b) Catéter urinario: Debe usarse técnica aséptica.

- Realizar aseo genital.
- Realizar lavado clínico de manos.
- Usar barreras protectoras: guantes estériles.
- Todo material a usar debe ser estéril incluido el lubricante, que además debe ser de uso individual.
- Usar campo estéril.
- Debe realizarse con la colaboración de asistente capacitado.

	PROTOCOLO DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE IAAS INSTITUCIONAL	Código:	GCL 3.2
		Fecha:	Noviembre 2025
		Versión:	1.0
		Vigencia:	Noviembre 2030
		Página:	Página 15 de 26

- Efectuar fijación externa del catéter con tela adhesiva para impedir su desplazamiento y tracción con el fin de prevenir el reflujo.
- La actividad debe ser registrada en Ficha Clínica (Hoja de urgencia o ficha clínica electrónica Rayen)
- Educar permanentemente al paciente o cuidador sobre los cuidados del sistema que incluya mantención del circuito y pesquisa de complicaciones.

4. USO DE ANTISÉPTICOS Y DESINFECTANTES.

Responsable de su aplicación: Todo el personal del establecimiento de acuerdo a sus funciones, responsabilidades y/o eventos especiales.

Generalidades:

- Los Antisépticos y Desinfectantes deben tener especificado el nombre del producto, concentración y fecha de vencimiento.
- Los desinfectantes se deben mantener en envases limpios, cerrados.
- Los antisépticos y desinfectantes deben ser almacenados protegidos de luz solar, en lugar seco, a temperatura ambiente, alejado de una fuente de calor y protegidos del polvo.

a) Uso de antisépticos.

Antiséptico, es una sustancia química con acción antimicrobiana que se aplica sobre la piel intacta. Es de baja toxicidad y puede ser aplicado sobre el ser humano para reducir el recuento microbiano en la superficie cutánea impidiendo la infección o la transmisión de microorganismos. En las manos permite controlar la microbiota transitoria y residente.

Recomendaciones.

- Antes de usar antisépticos, la zona debe estar libre de suciedad y materia orgánica visible.
- Se debe disponer de frascos de jabón antiséptico y antisépticos tópicos del menor tamaño posible para evitar su contaminación una vez abierto y usar el tiempo establecido.

	PROTOCOLO DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE IAAS INSTITUCIONAL	Código:	GCL 3.2
		Fecha:	Noviembre 2025
		Versión:	1.0
		Vigencia:	Noviembre 2030
		Página:	Página 16 de 26

- Al abrir envase con alcohol o clorhexidina se debe rotular con la fecha de apertura y fecha de caducidad a los 30 días.
- El jabón con antiséptico debe ser eliminado a los 30 días de su apertura.
- Previo a su uso se debe verificar la fecha de vigencia y que el envase esté indemne. Una vez abiertos los antisépticos deben permanecer cerrados en el área limpia.
- Los antisépticos deben ser agregados a las tómulas o gasas sólo en el momento de **SU USO**.
- Se debe esperar el tiempo de acción del antiséptico utilizado antes de realizar el procedimiento.
- Al elegir un jabón con antiséptico se deberá considerar el cuidado de la piel para prevenir dermatitis irritativa.

Tipo de Productos: Los Antisépticos aprobados para su uso son:

Antisépticos y su uso:

Jabones antisépticos:	Antisépticos Tópicos:
• Jabón Clorhexidina 2% • Alcohol Gel.	• Alcohol puro 70 ° • Clorhexidina jabonosa 2% • Clorhexidina 0,12% para colutorios bucales.

JABÓN CON ANTISÉPTICO	
Jabón de Clorhexidina 2%	Lavado de manos clínico.
	Lavado de heridas.
Alcohol Gel	Higiene de manos.
ANTISÉPTICOS TÓPICOS	
Solución de Clorhexidina	Asepsia de piel en procedimientos invasivos.

	PROTOCOLO DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE IAAS INSTITUCIONAL	Código:	GCL 3.2
		Fecha:	Noviembre 2025
		Versión:	1.0
		Vigencia:	Noviembre 2030
		Página:	Página 17 de 26

Alcohol puro 70 °	Asepsia de piel en procedimientos de corta duración.
Clorhexidina 0,12% para colutorios bucales.	Asepsia bucal en odontología.

b) Uso de desinfectantes:

Desinfectante es una sustancia química cuya finalidad es la eliminación de los microorganismos de superficies inanimadas posterior a la limpieza.

Recomendaciones:

- Los desinfectantes se deben mantener en envases limpios, cerrados y protegidos del polvo.
- Deben estar rotulados con el nombre del producto, concentración y fecha de vencimiento.
- Deben ser almacenados tapados, protegidos del polvo, luz y calor en un área limpia, mueble o bodega, de preferencia en envases originales.
- Todo desinfectante de superficies debe ser utilizado con barreras protectoras.
- Los desinfectantes deben aplicarse sobre superficies limpias.
- Los desinfectantes se deben usar en la dilución recomendada por el fabricante y de acuerdo al tipo de área a tratar.
- Durante el procedimiento de aseo la solución debe mantenerse limpia.
- Para optimizar el uso de desinfectantes se puede aplicar con rociador.

Tipo de Productos: Los Desinfectantes aprobados para su uso son:

Nivel Intermedio:	Nivel Bajo:
• Alcohol 70° • Hipoclorito de sodio 10%	• Amonio cuaternario 4^a generación.

	PROTOCOLO DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE IAAS INSTITUCIONAL	Código:	GCL 3.2
		Fecha:	Noviembre 2025
		Versión:	1.0
		Vigencia:	Noviembre 2030
		Página:	Página 18 de 26

Desinfectantes y su uso:

DESINFECCIÓN NIVEL INTERMEDIO	
Alcohol 70°	En instrumental como otoscopios, fonendoscopios, termómetros, monitores, bombas de infusión, parte externa de equipos médicos, superficies pequeñas como tapones de goma de medicamentos y superficies ambientales pequeñas como zona de preparación de medicamentos.
Cloro 1000 ppm	Equipos, muebles, pisos, chatas, patos, otros.
DESINFECCIÓN NIVEL BAJO	
Amonio cuaternario	Limpieza y desinfección de superficies de áreas clínicas.
	Los amonios cuaternarios se inactivan en presencia de materia orgánica, algodón, corcho, plástico y aguas duras.
LIMPIADOR DE USO DOMÉSTICO	
Aseo de todas las áreas no clínicas.	

Desinfección con Alcohol 70°:

Aquellas superficies que han estado en contacto directo con el paciente, deben ser desinfectadas entre paciente y paciente. Las demás superficies de las área clínicas, deben ser desinfectadas al final de cada jornada (mañana, tarde y vespertino). Superficies en contacto directo: camillas, balanzas, fonendoscopios, por ejemplo. Otras superficies: mesones de trabajo, pisos, paredes, contenedores de insumos, manillas de puertas.

Procedimiento:

- Limpiar la superficie rociando alcohol 70°. Repetir si fuera necesario.
- Secar por arrastre con toalla de papel.

	PROTOCOLO DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE IAAS INSTITUCIONAL	Código:	GCL 3.2
		Fecha:	Noviembre 2025
		Versión:	1.0
		Vigencia:	Noviembre 2030
		Página:	Página 19 de 26

Desinfección con soluciones de cloro:

El recipiente para el manejo del hipoclorito de sodio no debe contener ningún tipo de sustancia química o haber sido utilizada para consumo humano.

Procedimiento:

- Preparar la dilución al momento de usarla o al inicio de la jornada.
- De preferencia usar con paño empapado y dejar secar.
- El paño para la desinfección debe ser de uso exclusivo.

Desinfección con amonio cuaternario:

Limpieza y desinfección de superficies de áreas clínicas.

Procedimiento:

- Preparar la dilución al momento de su uso o al inicio de la jornada.
- Se puede utilizar rociador aplicando la mezcla preparada directo a la superficie o con paño empapado.
- El paño para la desinfección debe ser de uso exclusivo.

DESINFECTANTE	DILUCIÓN	TIEMPO DE ACCIÓN
Amonio cuaternario	Según indicaciones fabricante	10 min
Cloro 1000 ppm	1 sobre de cloro en polvo en 2.500 cc de agua	30 min
	10 cc de hipoclorito de sodio en 990 cc de agua	

	PROTOCOLO DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE IAAS INSTITUCIONAL	Código:	GCL 3.2
		Fecha:	Noviembre 2025
		Versión:	1.0
		Vigencia:	Noviembre 2030
		Página:	Página 20 de 26

Limpieza:

Procedimiento de Limpieza:

- Se utiliza: detergente de uso doméstico.
- Debe realizarse diariamente y cuando sea necesario.
- Usar guantes de uso doméstico.
- Usar el paño una vez por cada lado, los movimientos deben sobreponerse 2 cm de las zonas ya tratadas, para no arrastrar suciedad al área limpia.
- Limpiar superficie de muebles con paño humedecido en solución detergente
- Retirar detergente con paño humedecido en agua
- Limpiar con detergente los muros en lugares visiblemente sucios, con movimientos horizontales.
- Retirar detergente de los muros con paño humedecido en agua.
- Limpiar el piso con paño humedecido en la solución detergente (agrupando los muebles en lado limpio)
- Retirar el detergente del piso con paño humedecido en agua.
- Limpiar con detergente el lavamanos.
- Lavar paños y guardarlos en el recinto de aseo.
- Lavado de manos.

Procedimiento de Desinfección Concurrente.

- Se utiliza: amonio cuaternario o cloro.
- Se debe efectuar al menos una vez al día y las veces que sea necesario.
- Debe realizarse con guantes de uso doméstico.
- Siempre debe ir precedido de limpieza (seguir procedimiento anterior).
- Preparar la solución de desinfectante (por ej., cloro 0.1%) en recipiente.
- Humedecer el paño a usar en la solución desinfectante.

	PROTOCOLO DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE IAAS INSTITUCIONAL	Código:	GCL 3.2
		Fecha:	Noviembre 2025
		Versión:	1.0
		Vigencia:	Noviembre 2030
		Página:	Página 21 de 26

- Aplicar desinfectante con la siguiente secuencia y con su paño correspondiente: muebles, muros - lavamanos y finalmente piso, realizando movimientos en zigzag desde la zona más limpia a la más sucia, evitando repetir el paso del paño varias veces por el mismo sitio.
- Lavar y dejar secando los paños en el recinto de aseo.
- Lavado de manos.

Procedimiento de Desinfección Terminal:

- Se utiliza: amonio cuaternario
- Se realiza en todos los elementos que están en la habitación y planta física.
- El personal debe usar delantal y guantes a fin de proteger el vestuario y como precaución estándar.
- Secuencia: murallas, artefactos (excepto parte interna del W.C.) y pisos.
- Retirar la basura
- Limpiar mobiliario y agruparlo
- Limpiar murallas y lavamanos
- Limpiar pisos (agrupando los muebles en el lado limpio del piso)
- Completar la limpieza del piso.
- Este procedimiento deberá desarrollarse semanalmente en todas las áreas clínicas.

	PROTOCOLO DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE IAAS INSTITUCIONAL	Código:	GCL 3.2
		Fecha:	Noviembre 2025
		Versión:	1.0
		Vigencia:	Noviembre 2030
		Página:	Página 22 de 26

VII. INDICADORES.

NOMBRE DEL INDICADOR	Porcentaje de aprobación de pauta técnica de lavados de manos clínicos en personal de salud
TIPO	De proceso
DIMENSIÓN	Seguridad asistencial
FÓRMULA	$\left(\frac{\text{N}^\circ \text{ de personas con pauta de cotejo de técnica de lavado de manos clínico aprobada}}{\text{N}^\circ \text{ de personas con pauta de lavado de manos clínico aplicada}} \right) * 100$
UMBRAL DE CUMPLIMIENTO	Mayor igual al 85%
FUENTE DE INFORMACIÓN	Pauta de cotejo de técnica lavado de manos clínico. Gráficas de cumplimiento general y por ítem.
METODOLOGÍA	Muestreo por conveniencia de 15 personas semestralmente con una desviación estándar de 1 y margen de error de 0.5%. La evaluación será realizada con pauta de cotejo automatizada en Excel. La supervisión se hará según pauta supervisión directa según la oportunidad.
PERIODICIDAD	Semestral
RESPONSABLE	Enfermeras CESFAM y Postas, equipo de calidad

	PROTOCOLO DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE IAAS INSTITUCIONAL	Código:	GCL 3.2
		Fecha:	Noviembre 2025
		Versión:	1.0
		Vigencia:	Noviembre 2030
		Página:	Página 23 de 26

NOMBRE DEL INDICADOR	Porcentaje de aprobación de pauta de procedimiento de desinfección concurrente para el personal de aseo institucional.
TIPO	De proceso
DIMENSIÓN	Seguridad asistencial
FÓRMULA	$\left(\frac{\text{N}^\circ \text{ de auxiliares de servicio con pauta de cotejo de procedimiento de desinfección concurrente aprobada}}{\text{N}^\circ \text{ de auxiliares de servicio con pauta de cotejo de procedimiento de desinfección concurrente aplicadas}} \right) * 100$
UMBRAL DE CUMPLIMIENTO	Mayor igual al 80%
FUENTE DE INFORMACIÓN	Pauta de cotejo procedimiento de desinfección concurrente. Gráficas de cumplimiento general y por ítem.
METODOLOGÍA	Muestreo por conveniencia de 5 personas semestralmente con una desviación estándar de 1 y margen de error de 0.5%. La supervisión será realizada con pauta de cotejo automatizada en Excel.
PERIODICIDAD	Semestral
RESPONSABLE	Jefa Unidad de aseo y Enfermera IAAS

VIII. DISTRIBUCIÓN.

- Servicio de Urgencia Rural.
- Unidad Dental.
- Unidad Toma de muestras.
- Salas IRA, ERA.
- Postas de Salud Rurales.
- Sala Rehabilitación integral osteomuscular.

	PROTOCOLO DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE IAAS INSTITUCIONAL	Código:	GCL 3.2
		Fecha:	Noviembre 2025
		Versión:	1.0
		Vigencia:	Noviembre 2030
		Página:	Página 24 de 26

IX. BIBLIOGRAFÍA.

- Complejo Asistencial Barros Luco, 2012. Manual de Normas para la Prevención y Control de las infecciones asociadas a la atención en Salud (IAAS).
- Hospital Clínico Universidad de Chile, 2011. Prácticas para la prevención de infecciones asociadas a la atención de salud.
- MINISTERIO DE SALUD (MINSAL). 2011. Norma Técnica N°124 sobre Programas de Prevención y Control de las infecciones asociadas a la atención de salud (IMS).
- MINSAL, Subsecretaría de Redes Asistenciales. 2013. Circular N°9, Precauciones estándares para el control de las infecciones en la atención en Salud y algunas consideraciones sobre aislamiento de pacientes.

X. AUTORES.

- EU Sandy Guajardo P. Enfermera IAAS CESFAM Dr. Orlando Leyton A. Peralillo

XI. CONTROL DE CAMBIOS

Cambio	Fecha de cambio	Responsable del cambio (Firma)	Autoriza el cambio (Firma)

	PROTOCOLO DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE IAAS INSTITUCIONAL	Código:	GCL 3.2
		Fecha:	Noviembre 2025
		Versión:	1.0
		Vigencia:	Noviembre 2030
		Página:	Página 25 de 26

XII. ANEXOS.

Anexo 1: Técnica lavado de manos OMS.

¿Cómo lavarse las manos?

¡Lávese las manos solo cuando estén visiblemente sucias! Si no, utilice la solución alcohólica

⌚ Duración de todo el procedimiento: 40-60 segundos

- 

0 Mojese las manos con agua;
- 

1 Deposite en la palma de la mano una cantidad de jabón suficiente para cubrir todas las superficies de las manos;
- 

2 Frótese las palmas de las manos entre sí;
- 

3 Frótese la palma de la mano derecha contra el dorso de la mano izquierda entrelazando los dedos y viceversa;
- 

4 Frótese las palmas de las manos entre sí, con los dedos entrelazados;
- 

5 Frótese el dorso de los dedos de una mano con la palma de la mano opuesta, agarrándose los dedos;
- 

6 Frótese con un movimiento de rotación el pulgar izquierdo, atrapándolo con la palma de la mano derecha y viceversa;
- 

7 Frótese la punta de los dedos de la mano derecha contra la palma de la mano izquierda, haciendo un movimiento de rotación y viceversa;
- 

8 Enjuáguese las manos con agua;
- 

9 Séquese con una toalla desechable;
- 

10 Sirvase de la toalla para cerrar el grifo;
- 

11 Sus manos son seguras.



Organización Mundial de la Salud

Seguridad del Paciente

UNA ALTA RENDIDA, MÁS CON EFICACIA Y MÁS SEGURA

SAVE LIVES

Clean Your Hands

La Organización Mundial de la Salud (OMS) es una agencia especializada de las Naciones Unidas que se dedica a promover la salud, prevenir enfermedades y prolongar la vida humana. La OMS es la autoridad mundial en materia de salud pública y es responsable de la coordinación de las actividades de salud pública a nivel internacional. La OMS también es responsable de la supervisión y el control de las enfermedades infecciosas y de la salud pública en general. La OMS también es responsable de la supervisión y el control de la salud pública en general. La OMS también es responsable de la supervisión y el control de la salud pública en general.

